Resumos de Pediatria

Batistaz

*Caderno de Estudos* · Respiratório

# Asma na Criança

*Do controle à crise*

Internato de Pediatria

10º período · 2026.2

# Sumário

*Asma na criança e no adolescente · do controle à crise*


I — É asma? — 3
*Definição, história e o que mais chia*

II — Como confirmar o diagnóstico? — 4
*Os três critérios até 5 anos e a espirometria a partir de 6*

III — A asma está controlada? — 5
*Controle, gravidade da doença e risco futuro*

IV — Como tratar a criança até 5 anos? — 6
*Etapas, corticoide inalatório e espaçador*

V — E o escolar e o adolescente? — 7
*Etapas de 6 a 11 anos, CI-formoterol, doses de CI*

VI — A crise é leve, moderada ou grave? — 9
*Sinais, saturação, PFE e PRAM*

VII — Como tratar a crise no pronto-socorro? — 10
*Oxigênio, salbutamol, ipratrópio, corticoide*

VIII — Não respondeu: internar, UTI ou intubar? — 12
*Magnésio, critérios e o que não fazer*

IX — Quando dar alta e como evitar a próxima? — 13
*Alta, prescrição, retorno e plano de ação*

X — Mapa de decisão e pegadinhas — 14

XI — Questões de estudo — 15

— Gabarito, fontes e anotações — 16


## Como ler este caderno

**Cai na prova** — O que costuma ser cobrado ou confundido.

**Conduta** — O que fazer no plantão, em ordem.

**Atenção** — Armadilha clínica ou divergência entre diretrizes.

*As chaves entre colchetes indicam a fonte de cada dado: [MS] PCDT de Asma do Ministério da Saúde (2026), [ASBAI] guia ASBAI/SBP de exacerbação (2021), [GINA] GINA 2026, [SBP-NT] nota técnica SBP (2023). Lista completa no fim.*

Capítulo I

# É asma?

*Asma é doença heterogênea, com inflamação crônica das vias aéreas e sintomas que **variam** no tempo e na intensidade (sibilância, falta de ar, aperto no peito, tosse), com limitação variável do fluxo expiratório [MS] [SBP-NT].*

## *O que a história mostra*

- Sintomas que vão e voltam, pioram à noite ou ao acordar, com exercício, riso, choro, alérgenos, frio e infecções virais [MS].
- Atopia pessoal ou familiar apoia, mas sua ausência não exclui [MS].
- Na criança pequena, entre os episódios, tosse seca ou falta de ar que piora no sono ou depois de rir, chorar ou brincar [MS].

Tabela 1 · *Quando o chiado aponta para outra coisa*

| Pista | Pensar em |
|---|---|
| *Início súbito, engasgo, sibilo unilateral* | Corpo estranho |
| *Tosse ao mamar, engasgos, infecções de repetição* | Aspiração, refluxo |
| *Sintomas desde o nascimento, prematuridade* | Malformação, displasia broncopulmonar |
| *Tosse úmida persistente* | Bronquite bacteriana prolongada, bronquiectasia, tuberculose |
| *Baixo ganho de peso, fezes alteradas, secreção abundante* | Fibrose cística |
| *Estridor, tosse metálica, ruído ao chorar* | Malácia de via aérea, anel vascular |
| *Sopro, baixo crescimento* | Cardiopatia |
| *Infecções graves em outros sistemas* | Imunodeficiência |

*[GINA] [ASBAI]. Sinal focal, baqueteamento, sintoma contínuo, início muito precoce, déficit de crescimento ou falta de resposta com boa técnica pedem investigação [GINA].*

Cai na prova · nem todo chiado é asma

No lactente, o chiado da bronquiolite é obstrução por muco e edema, não broncoespasmo. A asma se diagnostica pela **recorrência**, pela exclusão de outra causa e pela resposta ao tratamento (capítulo II) [MS].

Atenção · AIDPI: sibilância primeiro

Na criança com tosse ou dificuldade para respirar e sibilância, o AIDPI manda tratar e reavaliar a sibilância antes de classificar pneumonia, salvo quadro grave: taquipneia de broncoespasmo não é pneumonia [AIDPI].

Capítulo II

# Como confirmar o diagnóstico?

## *Até 5 anos: três critérios juntos*

Tabela 2 · *Diagnóstico de asma na criança ≤ 5 anos (PCDT)*

| | |
|---|---|
| ***1. Recorrência*** | ≥ 2 episódios agudos de sibilância nos últimos 12 meses, ou ≥ 1 episódio + sintomas intermitentes em outro momento. Cada episódio dura > 24 h, e a sibilância é confirmada ao menos uma vez |
| ***2. Exclusão*** | Sintomas improváveis de serem explicados por outro diagnóstico (história e exame completos) |
| ***3. Resposta*** | Melhora em **20–60 min** após SABA; na crise moderada ou grave com corticoide oral, em **3–4 h**. Ou resposta a teste terapêutico de **2–3 meses** |

*[MS]. Critério incompleto: registrar **suspeita de asma**, tratar se indicado e reavaliar.*

**Teste terapêutico com CI diário**: indicado se houve ≥ 1 crise com atendimento de urgência, corticoide oral ou internação no último ano, ou sintomas mais de 2 vezes por semana. Beclometasona **100 mcg de 12/12 h**, reduzida para **50 mcg de 12/12 h** quando a resposta confirma o diagnóstico. Sintomas que voltam ao parar reforçam o diagnóstico [MS].

## *A partir de 6 anos: provar a variabilidade*

- **Espirometria** a partir dos 6 anos (às vezes antes); em geral é **normal** mesmo com doença ativa: normal não exclui [MS].
- Resposta ao broncodilatador: aumento do **VEF1 ≥ 12%** após 200–400 mcg de salbutamol, medido em 10–15 min; suspender o SABA ≥ 4 h antes, se tolerado [MS].
- PFE: variabilidade diária média > **13%** em 2 medidas por dia por 2 semanas, sempre no mesmo aparelho [MS].
- Broncoprovocação acima de 5 anos com sintomas compatíveis e espirometria normal [MS].

Atenção · 12% de quê?

O PCDT escreve VEF1 ≥ 12% **do basal** na criança; o GINA, ≥ 12% **do previsto**. Não são equivalentes: use a redação da fonte da questão [MS] [GINA]. O "≥ 200 mL" junto dos 12% é critério do **adulto**; na criança, o GINA não o exige [GINA].

## *Exames que não são rotina*

**Radiografia**: não é rotina; o PCDT admite pedi-la na avaliação inicial para o diagnóstico diferencial (corpo estranho, malformação, tuberculose) ou na complicação [MS] [ASBAI]. **Prick test ou IgE específica**: mostram sensibilização; negativos não excluem asma [MS]. **Hemograma**: afasta anemia e mostra eosinofilia [MS]. Espirometria não deve ser feita na suspeita de tuberculose [MS].

Capítulo III

# A asma está controlada?

*Três coisas diferentes: o **controle** nas últimas semanas, a **gravidade da doença** (pelo tratamento que ela exige) e a **gravidade da crise** (capítulo VI) [MS].*

Tabela 3 · *Controle dos sintomas nas últimas 4 semanas*

| ≥ 6 anos | ≤ 5 anos (PCDT) |
|---|---|
| *Sintomas diurnos > 2×/semana* | Sintomas diurnos por mais de alguns minutos, > 1×/semana |
| *Despertar noturno por asma* | Despertar ou tosse noturna |
| *SABA para sintomas > 2×/semana* | SABA > 1×/semana |
| *Limitação de atividades* | Limitação de atividades |
| ***Nenhum item: controlada · 1–2: parcialmente controlada · 3–4: não controlada*** | |

*[MS]. O GINA atual usa > 2×/semana também para ≤ 5 anos [GINA]. ACT (≥ 12 anos): controlada ≥ 20; c-ACT (4–11 anos): controlada > 19 [MS].*

## *Gravidade da doença*

- **Leve**: controlada com tratamento de baixa intensidade com CI.
- **Moderada**: precisa das etapas 3 ou 4 (CI-LABA em dose baixa ou média).
- **Grave**: não controlada apesar de CI-LABA em dose alta otimizado, ou precisa dele para ficar controlada — depois de corrigir técnica, adesão, exposição e comorbidades [MS].

## *Risco futuro: avaliar mesmo com sintomas controlados*

≥ 1 exacerbação no último ano, tratamento só com SABA, uso excessivo de SABA (mais de 3 frascos de 200 doses por ano), má adesão ou técnica errada com o CI, VEF1 reduzido, tabagismo, eosinofilia e vulnerabilidade social [MS].

Cai na prova · controlada não quer dizer leve

A criança que só está controlada com CI-LABA em dose média tem asma **moderada**, por mais que esteja sem sintomas. A gravidade se mede pelo tratamento necessário, depois de 2–3 meses de tratamento [MS].

Conduta · antes de subir uma etapa

- Confirmar que os sintomas são de asma.
- Ver a técnica inalatória na frente do paciente e checar a adesão.
- Rever exposições (fumaça, mofo, alérgenos) e comorbidades (rinite, refluxo) [MS].

Capítulo IV

# Como tratar a criança até 5 anos?

*Toda criança com asma ou suspeita de asma recebe **SABA inalatório** para alívio. Controlador diário com **CI** se sintomas mais de 2 vezes por semana ou ≥ 1 exacerbação grave com atendimento não programado no último ano [MS].*

Tabela 4 · *Etapas até 5 anos*

| Etapa | Tratamento |
|---|---|
| *1* | Sibilância viral infrequente, pouco ou nenhum sintoma entre os episódios: SABA sob demanda; considerar CI intermitente no início da virose |
| *2* | **CI diário em dose baixa** por pelo menos 2–3 meses (ou CI intermitente com os sintomas). Sibilância viral frequente com sintomas entre as crises: fazer antes o teste com CI diário |
| *3* | **Dobrar** a dose baixa de CI; considerar especialista |
| *4* | Manter e **encaminhar**; CI-LABA só com especialista (evidência a partir de 4 anos) |

*[MS]. Em todas as etapas, alívio com SABA sob demanda. Dose baixa: beclometasona (pMDI, partícula padrão) 100 mcg/dia [MS]; budesonida nebulizada 500 mcg/dia [GINA].*

### Técnica: pMDI com espaçador

- Dispositivo de pó não serve para a maioria das crianças ≤ 5 anos: **pMDI com espaçador** [MS].
- Agitar, **1 jato por vez**, 5–6 respirações no espaçador após cada jato [GINA].
- Máscara vedando nariz e boca; passar ao **bocal** assim que a criança conseguir [MS] [GINA].



pMDI com espaçador e bocal. *O jato vai para a câmara, e a criança respira por ela; sem espaçador, quase nada chega ao pulmão.*

### Conduta · plano em casa (até 5 anos)

Sinais de crise: mais tosse (sobretudo noturna), letargia, comer pior, SABA que não resolve. Começar SABA e reavaliar em até 1 h. Procurar atendimento se prostrada, sem resposta ou piorando (sobretudo < 1 ano), se precisar de ≥ 4 jatos em 4 h ou de SABA mais de 3 vezes nas primeiras 12 h. **Corticoide oral não é iniciado pelos pais** em casa [MS].

### Atenção · MART não é para o pré-escolar

Não há estudos de manutenção e alívio com CI-formoterol abaixo de 5 anos [GINA]; a nota da SBP fala em uso a partir de 6 anos [SBP-NT].

Capítulo V

# E o escolar e o adolescente?

## *6 a 11 anos (PCDT)*

Tabela 5 · *Etapa inicial pelo quadro de 6 a 11 anos*

| Quadro | Tratamento |
|---|---|
| *Sintomas ≤ 1–2 dias/semana* | **Etapa 1**: CI em dose baixa **sempre que usar o SABA** (inaladores juntos ou separados) |
| *Sintomas 2–5 dias/semana* | **Etapa 2**: CI diário em dose baixa + SABA sob demanda (ou CI sempre que usar SABA) |
| *Sintomas na maioria dos dias ou despertar ≥ 1×/semana* | **Etapa 3**: CI-LABA em dose baixa ou CI em dose média + SABA |
| *Sintomas diários, despertares, função reduzida* | **Etapa 4**: CI-LABA em dose média + SABA |
| *Sem controle na etapa 4* | **Etapa 5**: especialista, fenotipagem, terapia adicional |

*[MS]. O GINA 2026 acrescenta, de 6 a 11 anos, CI-formoterol só sob demanda na etapa 1 e manutenção e alívio (MART) nas etapas 3–4 [GINA]. A SBP apoia CI-formoterol (MART) a partir de 6 anos [SBP-NT].*

## *Doses de corticoide inalatório (dose diária total)*

Tabela 6 · *Dose baixa, média e alta*

| Fármaco (partícula padrão) | Baixa | Média | Alta |
|---|---|---|---|
| *6 a 11 anos (mcg/dia)* | | | |
| *Beclometasona pMDI* | 100–200 | > 200–400 | > 400 |
| *Budesonida (DPI ou pMDI)* | 100–200 | > 200–400 | > 400 |
| *≥ 12 anos (mcg/dia)* | | | |
| *Beclometasona pMDI* | 200–500 | > 500–1.000 | > 1.000 |
| *Budesonida (DPI ou pMDI)* | 200–400 | > 400–800 | > 800 |

*[MS]. Faixas de dose, não tabela de equivalência; a dose baixa basta para a maioria.*

Cai na prova · qual combinação serve de alívio

Só CI com **formoterol**, que age rápido. CI-salmeterol (início lento) e CI-vilanterol ou indacaterol (sem segurança com várias doses ao dia) **não** servem de alívio; e CI-formoterol de alívio não se soma a manutenção com outro LABA [MS].

### *12 anos ou mais: dois regimes*

Tabela 7 · *Regime preferencial: budesonida-formoterol 200/6 mcg (dose medida)*

| Etapa | Uso |
|---|---|
| *1 e 2* | **1 inalação sob demanda**, sem manutenção (alívio anti-inflamatório, AIR) |
| *3* | 1 inalação 1 ou 2 vezes ao dia + 1 sob demanda (MART) |
| *4 e 5* | 2 inalações 2 vezes ao dia + 1 sob demanda |

***Máximo: 12 inalações por dia*** *(72 mcg de formoterol), somando manutenção e alívio; precisar de mais em 24 h: procurar atendimento [GINA]*

*[MS]. 200/6 mcg medida = 160/4,5 mcg liberada. De 6 a 11 anos usa-se a apresentação 100/6 mcg [MS].*

**Regime alternativo** (quando o preferencial não é viável, ou paciente estável, aderente e sem exacerbações no último ano): etapa 1, CI sempre que usar SABA; etapa 2, CI diário em dose baixa + SABA; etapa 3, CI-LABA em dose baixa ou CI em dose média; etapa 4, CI-LABA em dose média [MS].

### *Reduzir e acompanhar*

- Reduzir só após pelo menos **3 meses** estável; em adolescentes, cortes de 25–50% a cada 3 meses. Não suspender o CI por completo [MS].
- Espirometria no início, em 3–6 meses e, em uso contínuo, a cada 6 meses [MS].
- Prevenção: adesão ao CI, técnica revista a cada consulta, eliminar fumaça de cigarro e vape, mofo e alérgenos relevantes, atividade física, vacinação em dia [MS].

Atenção · asma grave (etapa 5)

Encaminhar ao especialista para fenotipagem. Imunobiológicos do PCDT para criança: mepolizumabe 40 mg SC a cada 4 semanas (6–11 anos) ou 100 mg (≥ 12 anos); omalizumabe pela IgE e pelo peso; dupilumabe. Tiotrópio não está incorporado no SUS para asma [MS].

Cai na prova · SABA sozinho não é tratamento

O uso exclusivo de SABA não é recomendado: o excesso de SABA aumenta o risco de crise e até de morte por asma. Na alta de uma crise, sempre sair com **tratamento que contenha CI** [MS].

Capítulo VI

# A crise é leve, moderada ou grave?

*Avaliar enquanto já trata. A criança, e sobretudo o lactente, fica hipoxêmica mais rápido que o adulto [ASBAI].*

Tabela 8 · *Gravidade da crise*

| | Leve | Moderada | Grave |
|---|---|---|---|
| *Fala e postura* | Falta de ar ao andar, deita, fala frases | Falta de ar em repouso, prefere sentar, fala frases curtas, agitada | Sentada ereta, fala palavras; sonolenta ou confusa nos muito graves |
| *Esforço* | Sem musculatura acessória | Musculatura acessória | Acessória acentuada |
| *Sibilos* | Esparsos, fim da expiração | Difusos, expiratórios | Inspiratórios e expiratórios; **tórax silencioso** nos muito graves |
| *PFE (% previsto)* | ≥ 70% | 40–69% | < 40% |
| *SatO2 em ar* | > 95% | 90–95% (< 5 a: 92–95%) | < 90% (< 5 a: < 92%); cianose |

*[ASBAI]. Bradicardia nos casos muito graves. Hipercapnia surge mais rápido na criança pequena.*

### Saturação

Na criança, SatO2 < **92%** prediz internação, e < **90%** pede tratamento mais agressivo [ASBAI] [MS]. No início do salbutamol a saturação pode cair 5% ou mais nos primeiros 30 min (desequilíbrio ventilação-perfusão) [ASBAI].

### PFE (escolar)

< 50% do previsto: atendimento imediato; < 35%: risco de vida [ASBAI].

### PRAM (2 a 17 anos)

| | |
|---|---|
| *Retração supraesternal* | 0 / 2 |
| *Contração de escalenos* | 0 / 2 |
| *Entrada de ar: normal 0 · reduzida nas bases 1 · redução difusa 2 · mínima ou ausente 3* | 0 a 3 |
| *Sibilos: ausentes 0 · só expiratórios 1 · inspiratórios (± expiratórios) 2 · audíveis sem estetoscópio ou tórax silencioso 3* | 0 a 3 |
| *SatO2 ≥ 95 / 92–94 / < 92%* | 0 / 1 / 2 |

Leve 0–3 · moderada 4–7 · grave 8–12 [ASBAI] [GINA].

**Atenção · pouco sibilo pode ser o pior**

Sibilo audível costuma ser crise moderada; a ausência de sibilo com pouca entrada de ar (**tórax silencioso**), sonolência, cianose ou esforço que diminui sem melhora são sinais de ameaça à vida [ASBAI] [GINA]. Procurar também pneumotórax, pneumonia, corpo estranho e anafilaxia; se houver **anafilaxia**, adrenalina IM **primeiro**, depois o broncodilatador [MS] [GINA].

Capítulo VII

# Como tratar a crise no pronto-socorro?

*Tratar já, enquanto se faz uma anamnese breve. Os três pilares:* ***oxigênio*** *se hipoxêmico,* ***broncodilatador*** *repetido e* ***corticoide sistêmico*** *precoce [MS] [ASBAI].*

Tabela 9 · *Primeira hora*

| Medida | Dose e modo |
|---|---|
| ***Oxigênio*** | Cateter ou máscara (1–3 L/min costuma bastar), titulado para **SatO2 ≥ 94%** [ASBAI]. O GINA inicia se < 92% e mira 92–95% no escolar e ≥ 92% no pré-escolar [GINA] |
| ***Salbutamol*** | pMDI 100 mcg com espaçador, **1 jato por vez**: 4–10 jatos a cada 20 min na 1ª hora [MS]. Por peso: 5–10 kg 4 jatos · 10–20 kg 6 jatos · > 20 kg 8 jatos [ASBAI]. Pré-escolar com crise moderada ou grave: 4–6 jatos, até 3 vezes, a cada 20–30 min [GINA]. Nebulização se não coopera ou crise muito grave; no ≤ 5 anos, 2,5 mg por dose [GINA] [ASBAI] |
| ***Ipratrópio*** | Só junto com o SABA, na crise moderada ou grave: nebulização 125–250 mcg (< 4 anos) ou 250–500 mcg (≥ 4 anos), até 3 vezes a cada 20 min na 1ª hora [ASBAI]; ou 4 jatos de 20 mcg [GINA]. Sem benefício depois de 1–2 h [GINA] |
| ***Corticoide*** | Na 1ª hora, em toda crise moderada ou grave; **via oral**, tão eficaz quanto a venosa. Venosa (hidrocortisona, metilprednisolona) se vomita, não engole ou vai para VNI ou intubação. Leva cerca de 4 h para agir [ASBAI] |

Tabela 10 · *Corticoide oral na crise (prednisolona ou prednisona)*

| Idade | Dose | Duração |
|---|---|---|
| *< 2 anos* | 1–2 mg/kg/dia, máx. **20 mg/dia** | 3–5 dias |
| *2–5 anos* | 1–2 mg/kg/dia, máx. **30 mg/dia** | 3–5 dias |
| *6–11 anos* | 1–2 mg/kg/dia, máx. **40 mg/dia** | 3–5 dias |
| *Adolescente* | 40–50 mg/dia | 5–7 dias |
| *Alternativa* | Dexametasona VO 0,3–0,6 mg/kg (máx. 12 mg), 1 dose, com ou sem 2ª no dia seguinte | 1–2 dias |

*[ASBAI] [GINA] [MS]. Dose única pela manhã; sem desmame se < 2 semanas [MS]. Recaída com dexametasona: trocar por prednisolona [GINA].*

### *Reavaliar e decidir*

- Reavaliar a cada **20–30 min na 1ª hora**: consciência, FR, FC, SatO2, musculatura acessória, retrações; nenhum parâmetro sozinho decide [ASBAI].
- Pré-escolar: sem resposta em 1 h, SABA necessário a cada 1–2 h ou desconforto depois de 4–6 h do corticoide: pensar em internação [GINA].
- Leve ou moderada que piora ou não responde ao broncodilatador e ao corticoide depois de **2 h** de atendimento: internar [ASBAI].

### *Exames na crise*

**Gasometria** não é rotina: PFE ou VEF1 < 50%, má evolução ou SatO2 < 92%. PaCO2 normal ou alta numa crise importante é sinal de piora. **Radiografia** só se não responde ou há sinal de complicação (pneumotórax, consolidação). Outros exames raramente ajudam [ASBAI].

Atenção · a taquipneia que não melhora pode ser do salbutamol

Doses altas de SABA causam taquicardia, hipocalemia, arritmia e **acidose láctica**, que aumenta a FR e parece piora da obstrução, levando a ainda mais salbutamol [GINA].

Cai na prova · espaçador não é inferior

pMDI com espaçador é a via preferida na crise leve e moderada; a nebulização fica para quem não coopera ou está muito grave [ASBAI] [GINA]. E corticoide **venoso não é superior ao oral** quando a criança engole [ASBAI].

Conduta · roteiro da 1ª hora

- Monitor, oxímetro; O2 se hipoxêmico.
- Salbutamol com espaçador a cada 20 min, 3 vezes; ipratrópio junto se moderada ou grave.
- Prednisolona oral 1–2 mg/kg (teto pela idade) ainda na 1ª hora.
- Reavaliar a cada 20–30 min; decidir em 1–2 h: alta, observação ou internação.

Capítulo VIII

# Não respondeu: internar, UTI ou intubar?

### *Sulfato de magnésio venoso*

Não é rotina. Na crise **grave sem resposta ao tratamento inicial**, acima de 2 anos: dose única de **25–75 mg/kg** em 20 min (máx. 2–2,5 g) [ASBAI]; o GINA usa **40–50 mg/kg, máx. 2 g**, em infusão lenta, depois da 1ª hora [GINA]. Reduz internações. Magnésio nebulizado não tem benefício consistente [ASBAI] [GINA].

**Segunda linha na grave refratária**, todas com evidência fraca e na UTI: salbutamol ou terbutalina **venosos** (só se a via inalatória é impossível, com monitorização: com terbutalina houve arritmia e troponina alta), **adrenalina**, **heliox** e cetamina no intubado. Aminofilina só na UTI, com dosagem sérica [ASBAI].

Tabela 11 · *Para onde vai a criança*

| Destino | Critérios |
|---|---|
| ***Internação*** *(absolutos)* | Piora da dispneia ou do esforço · fadiga (FR e retração diminuindo, assincronia tóraco-abdominal) · **tórax silencioso** ou não consegue falar · $O_2$ ainda necessário 1 h depois do tratamento inicial · história de asma quase fatal (UTI, intubação) |
| *Internação (relativos)* | Crises anteriores com piora rápida · má adesão, uso frequente de SABA · vulnerabilidade social, cuidador sem condições |
| ***UTI*** | Não consegue falar, confusão ou sonolência · hipoxemia apesar do $O_2$ · hipercapnia moderada a grave. Crise que chega classificada como grave já vai para UTI pediátrica |
| ***Intubação*** | Esforço grave persistente com alteração mental · $PaO_2 < 60$ mmHg com $O_2$ a 100% ou VNI · hipercapnia progressiva com acidose ou alteração mental · parada |

*[ASBAI]*

Tabela 12 · *O que não fazer na crise*

| | | |
|---|---|---|
| *Antibiótico* | **Não** | Não de rotina: a crise costuma ser viral ou ambiental. Tratar se houver infecção bacteriana associada, como pneumonia [ASBAI] [GINA] |
| *Aminofilina, teofilina* | **Não** | Risco maior que o benefício [GINA] |
| *Sedativo* | **Não** | Deprime o drive respiratório [GINA] |
| *Radiografia de rotina* | **Não** | Raramente muda a conduta [ASBAI] |
| *Alto fluxo como rotina* | **Não** | Sem benefício demonstrado na crise asmática; VNI pode ser tentada na grave que falha, com vigilância [ASBAI] |

Capítulo IX

# Quando dar alta e como evitar a próxima?

### Pode ir para casa se

- Estável: fora do leito, sem O2 suplementar, come e bebe sem dificuldade [ASBAI] [GINA].
- Pré-escolar: sem recorrência por pelo menos 1–2 h [GINA].
- Escolar: PFE ou VEF1 de 60–80% do previsto ou do melhor pessoal, com melhora clínica [ASBAI].
- Voltar se precisar de SABA de novo em menos de 4 h [GINA].

### Prescrição de alta

- **Alívio sob demanda**, anotando o uso diário [ASBAI] [GINA].
- Completar o **corticoide oral**: 3–5 dias na criança, 5–7 no adolescente [ASBAI] [MS].
- **Iniciar CI** se não usava; quem já usava intensifica por 2–4 semanas [ASBAI] [MS].
- Na alta, tratamento conforme as etapas 3 ou 4; **nunca só SABA** [MS].

Tabela 13 · *Retorno depois da crise*

| | |
|---|---|
| *Criança (ASBAI/SBP)* | 1–2 dias; adolescente, 2–7 dias; e outra consulta em 1–2 meses |
| *Até 5 anos (PCDT, GINA)* | 1–2 dias (PCDT) · 1–3 dias (GINA) |
| *Geral (PCDT)* | 2–7 dias; o GINA usa 2–5 dias para crianças |

*[ASBAI] [MS] [GINA]. Encaminhar ao especialista: ≥ 6 anos, se já houve ≥ 1 crise com corticoide oral ou atendimento de urgência nos últimos 12 meses; ≤ 5 anos, se ≥ 1 crise no período [GINA].*

### Conduta · educação antes de sair

- Ver a técnica com o dispositivo na mão do paciente; conferir acesso ao remédio.
- **Plano de ação por escrito**: remédios e doses, sinais de piora, onde procurar atendimento.
- Procurar atendimento já se: falta de ar aguda, broncodilatador que não alivia, alívio cada vez mais curto, menor de 1 ano precisando de SABA repetido, mais de 6 jatos nas primeiras 2 h [ASBAI].
- Identificar gatilhos e fatores de risco da crise [ASBAI].

### Atenção · "SABA de 4/4 h por 7 dias"

Os fluxogramas do guia brasileiro de 2021 e o AIDPI ainda prescrevem salbutamol em horário fixo na alta [ASBAI] [AIDPI]; o próprio guia, o GINA e o PCDT orientam alívio **sob demanda** com tratamento de manutenção com CI [ASBAI] [GINA] [MS].

Capítulo X

# Mapa de decisão e pegadinhas

| | |
|---|---|
| 1 · É asma? | Sintomas variáveis e recorrentes; afastar corpo estranho, aspiração, fibrose cística, malácia, cardiopatia. |
| 2 · Confirmar | ≤ 5 anos: recorrência + exclusão + resposta. ≥ 6 anos: espirometria (VEF1 ≥ 12%) ou PFE > 13%. |
| 3 · Controle | 4 itens em 4 semanas; gravidade pela etapa necessária; risco futuro à parte. |
| 4 · Manter | ≤ 5: SABA + CI diário se > 2×/sem ou crise grave. 6–11: CI sempre que SABA → CI diário → CI-LABA. ≥ 12: budesonida-formoterol sob demanda/MART. |
| 5 · Crise | O2 (SatO2 ≥ 94%), salbutamol 20/20 min ×3 com espaçador, ipratrópio se moderada/grave, prednisolona na 1ª hora. |
| 6 · Escalar | Sem resposta: magnésio IV > 2 anos; internar; UTI se fala prejudicada, sonolência, hipoxemia com O2, hipercapnia. |
| 7 · Alta | Estável, sem O2; corticoide até o fim; iniciar CI; técnica, plano escrito, retorno em 1–2 dias. |

Tabela 14 · *Pegadinhas de decisão*

| Afirmação tentadora | Correção |
|---|---|
| *Não dá para diagnosticar asma no pré-escolar* | Dá: três critérios; se incompletos, "suspeita de asma" e reavaliar |
| *Espirometria normal exclui asma* | Costuma ser normal na criança, mesmo com doença ativa |
| *Pouco sibilo, crise leve* | Tórax silencioso é obstrução extrema |
| *Nebulizar é mais forte que o espaçador* | Espaçador é a via preferida na crise leve e moderada |
| *Corticoide venoso age melhor* | Oral é tão eficaz se a criança engole |
| *Toda crise pede RX e antibiótico* | Nenhum dos dois é rotina |
| *Asmático não pode tomar ibuprofeno* | Pode, salvo asma induzida por anti-inflamatório [SBP-F] |
| *Qualquer CI-LABA serve de alívio* | Só com formoterol |
| *Alta só com salbutamol* | Sempre com tratamento contendo CI |

Capítulo XI

# Questões de estudo

**1.** Menino de 3 anos com 3 episódios de chiado no último ano, cada um com mais de 24 h, um com atendimento de urgência e corticoide oral; tosse noturna entre as crises; melhora com salbutamol; história e exame não sugerem outro diagnóstico. Pelo PCDT:

A Não se diagnostica asma antes dos 6 anos.
B Pode-se diagnosticar asma e iniciar CI diário em dose baixa.
C Basta salbutamol de horário.
D Deve-se fazer espirometria antes de tratar.

**2.** Escolar de 9 anos com sintomas 1 dia por semana, sem despertares. Pelo PCDT, o tratamento inicial é:

A Salbutamol sob demanda isolado.
B CI em dose baixa sempre que usar o SABA.
C CI-LABA em dose média.
D Montelucaste.

**3.** Criança de 7 anos em crise: fala frases curtas, musculatura acessória, sibilos difusos, SatO2 91%. A conduta inicial é:

A Aminofilina venosa.
B O2, salbutamol com espaçador a cada 20 min, ipratrópio e prednisolona oral na 1ª hora.
C Radiografia de tórax antes de tratar.
D Amoxicilina e nebulização com soro.

**4.** Lactente de 18 meses em crise moderada. A dose de prednisolona é:

A 1–2 mg/kg/dia, máximo 20 mg/dia, 3–5 dias.
B 1–2 mg/kg/dia, máximo 60 mg/dia, 10 dias.
C 40–50 mg/dia por 7 dias.
D Não se usa corticoide abaixo de 2 anos.

**5.** Durante o tratamento de uma crise, a criança fica sonolenta, os sibilos somem e a entrada de ar quase desaparece. Isso indica:

A Melhora: suspender o salbutamol.
B Obstrução extrema e ameaça à vida: UTI e preparar via aérea.
C Efeito colateral do ipratrópio.
D Crise leve.

**6.** Adolescente de 14 anos com sintomas 1–2 dias por semana. O regime preferencial do PCDT é:

A Salbutamol sob demanda isolado.
B Budesonida-formoterol 200/6 mcg, 1 inalação sob demanda.
C Salmeterol-fluticasona como alívio.
D Corticoide oral em ciclos.

### Gabarito comentado

**1 · B.** Recorrência (≥ 2 episódios > 24 h em 12 meses), sem outra explicação e com resposta ao SABA: asma. Crise com urgência e corticoide indica CI diário [MS].

**2 · B.** De 6 a 11 anos com sintomas ≤ 1–2 dias/semana: etapa 1, CI em dose baixa sempre que usar SABA. SABA isolado não é recomendado [MS].

**3 · B.** Crise moderada a grave: O2, SABA repetido, ipratrópio associado e corticoide oral precoce. Aminofilina, RX de rotina e antibiótico não [ASBAI] [GINA].

**4 · A.** Abaixo de 2 anos, máximo de 20 mg/dia por 3–5 dias [ASBAI] [GINA].

**5 · B.** Tórax silencioso com sonolência é falência iminente [ASBAI] [GINA].

**6 · B.** Etapas 1–2 no regime preferencial: CI-formoterol sob demanda. CI-salmeterol não serve de alívio [MS].

Apêndice

# Fontes e anotações


- [MS] BRASIL. Ministério da Saúde. *Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Asma*. Portaria Conjunta SAES/SCTIE n.º 43, de 24 mar. 2026.
- [ASBAI] PASTORINO, A. C. et al. Guia prático de atualização ASBAI e SBP para o tratamento da exacerbação de asma na criança e no adolescente. *Arq Asma Alerg Imunol*, v. 5, n. 4, 2021.
- [GINA] GLOBAL INITIATIVE FOR ASTHMA. *Global strategy for asthma management and prevention*, 2026.
- [SBP-NT] SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Nota técnica n.º 87: corticosteroide inalado associado a beta-agonista de longa duração na terapia de alívio e de manutenção da asma em crianças maiores de 6 anos e adolescentes, ago. 2023.
- [AIDPI] BRASIL. Ministério da Saúde; OPAS. *Manual de quadros de procedimentos: AIDPI Criança*, 2017.
- [SBP-F] SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. *Manejo da febre aguda*, 2021.


### Créditos das imagens

- *Treating Kids with Asthma.jpg*: The U.S. Food and Drug Administration, domínio público. Wikimedia Commons.

### Anotações